جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : نصره عبد العزيز احمد نصر
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** الجيزه **العنوان :** المنصوريه
رقم البطاقة : 27302102104003 **رقم التليفون :** 01116439124 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 10-02-1973 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: نصره عبد العزيز احمد نصر
National ID: 27302102104003

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



National ID - Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]



National ID · Back
[[DOCTYPE:ID_BACK]]

Name: ناصرة عبد العزيز احمد نصر **MR. :** 4173	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالتها

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها

The patient is a 50-year-old individual with luminal-type breast cancer managed initially with upfront surgery (lumpectomy) followed by placement of a port and adjuvant tamoxifen therapy. The most recent bone scan performed in December 2025 was negative for metastatic disease, and the patient is currently free of disease.

The patient is on tamoxifen 20 mg daily and calcium supplementation (1 tablet daily). The treatment plan includes continuation of tamoxifen, with the next scheduled dose of zoledex to be omitted in April 2026, and monitoring of estradiol (E2) and follicle-stimulating hormone (FSH) levels in June 2026.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : اسماء محمد مصطفي نصر

يعتمد ,

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : نصره عبدالعزيز احمد نصر Sex: Female
3- Medical number 81224668 (DD Mo5 16.11.2023)

2-ID number

Patient Age : 48Y

Family history	No yes	Phone	01116439123	BMI	REASON OF MDT
marital status		NRS Score		GROUP	Date of MDT 09/11/2023
Co morbidity	No htn	Menopausal status		Initial STAGE	

Clinical data

Breast Imaging :
R breast mass 17 x 13 mm

Mets Workup :
cap: D12 sclerotic lesion

BX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	Ki67
IDC	8/8	7/8	2	Not Amplified	5

T	N	M
2	0	0

Sonomammography

PATIENT HISTORY
LT WLE+SLNB :IDC GII , focal DCIS
free LN 0/3 , margin

MDT OUTCOME & PLAN

FOR E2 AND FSH
IF PREMENOPAUSAL FOR TAM ZOLADEX X 24 Then assess f menc state
PORT

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

MDT form

A-Patient ID:
1- Name :
Sex :
3- Medical number: 83224568
Female
Old Med
2014-2024
2-ID number:
Patient Age :
MDT
0 0

Family history		Phone		BMI	REASON OF MDT
marital status		NRS Score		GROUP	Date of MDT
Co morbidity		Menopausal status		Initial STAGE	

Clinical data

Breast Imaging :
rt breast mass 17 x18 mm

Mets WorkUp .

BX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	Ki67
IDC	8/8	8/8	2	Not Amplified	8

T	N	M
2	0	0

Sonomammography

PATIENT HISTORY
cap: D12 sclerotic lesion
bone scan:free

MDT OUTCOME & PLAN

- For Target axillary US ,
upfront lt breast conservative and SLN

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Patient Name	: الأستاذه / نصره عبد العزيز احمد	Request No.	: 13005862
Patient No.	: 27302102104003	Request Date	: 24/07/2024
Path No.	: 2574/24	Verification Date	: 27/08/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 51 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass.
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 23/07/2024.

Technique:
- Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against: Her2 clone (4B5) & SISH.

Results:
* IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- Her2: Moderate and complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 2+).
-SISH: Not Amplified.
Average Her2 copy No. > (1.65), Her2/CEP17 ratio > (1.17)

Conclusion:
Left breast mass, Tru-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade II with focal DCIS.
IPT:
- Her2: Equivocal (score 2+) .
- SISH: Not Amplified.

Signature
Dr. Walaa Ghonim.
Dr. Sagda Elkady.

Verified by :
Dr. Sagda El-Kady

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / نصره عبد العزيز احمد	Request No.	: 13006506
Patient No.	: 27302102104003	Request Date	: 07/10/2024
Path No.	: 3800/24	Verification Date	: 27/10/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 51 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, Up-Front
Nature Specimen: Left WLE and SLNs.

Gross Examination:
* Left SLN: A fibro fatty tissue piece measured 4x3 cm entangling 3 nodules up to 2x1 cm.
* Left WLE specimen measured 7.5x4.5x3 cm, with covering skin ellipse measured 4.5x2 cm
* Tumor extent: A firm grayish white tumor bed site
- Size: 3x2x1 cm
* Distance from margins: 0.5 cm from (medial margin)

Microscopic Examination:
* Left breast, WLE and SLNs biopsy:
* Histological Type: Invasive duct carcinoma.
* Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II.
* Ductal carcinoma in situ: Focal (intermediate grade , solid and cribriform).
* Lymph node involvement: Free SLNs (0/3).
* Angioinvasion: No.
* Perineural invasion: No.
* Resection Margins: Free.
Frozen section results:
Free margins.
Free SLNs (0/3).

Diagnosis:
Left breast, WLE and SLNs Biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade II with focal DCIS.
Free margins.
Free SLNs (0/3).

Verified by :
Dr. Sagda El-Kady

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / نصره عبد العزيز احمد	Request No.	: 13006506
Patient No.	: 27302102104003	Request Date	: 07/10/2024
Path No.	: 3800/24	Verification Date	: 27/10/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 51 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Stage: pT2, pN0.

Signature
Dr.Marwa Mahmoud.
Dr. Sagda Elkady.

Verified by :
Dr. Sagda El-Kady

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]
Mammogram

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــــحة والسكـــان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Nasra Abdel Aziz Ahmed Nasr	Date : 23/07/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 51 Year(s)
Medical ID: 27302102104003	Pat. ID: 76666

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO views DBT (Digital Breast Tomosynthesis).
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B).
- Left breast LIQ speculated dense lesion corresponding by US to hypoechoic irregular lesion 17 x 18 mm seen about 81 mm from the nipple and reaching the skin.
- No right breast solid or cystic mass lesions.
- Normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Solitary prominent left axillary lymph nodes showing diffuse cortical thickening reaching 4 mm.
- Nonspecific right axillary LNs.

Opinion:

- Left breast lesion as described (BIRADS 4) for histopathological correlation.
- Solitary prominent left axillary lymph nodes for FNAC.

Yours truly

Dr. Ali Saber, MSc.

[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]
Mammogram

Medical No. : 10804

Patient's Name: Nasra Abdel-Aziz Ahmed Nasr

Date: 2026-10-17

Referred by: Prof.Dr. no doctor

Hospital: Goustave Roussey International Egypt

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: Status post left CBS followed , routine follow up study.

Findings:

Left breast.

- Scattered fibroglandular densities. (ACR b)
- Thickened skin and coarsen trabeculae.
- Para arealor architectural distortion with no speculations, masses, asymmetry, or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated area of parenchymal disruption underneath the operative scar with no solid, cystic lesions or fluid collections.
- Thickened skin and coarsen trabeculae.
- Clear left axilla. No pathological infra or supra-clavicular lymph nodes

Right breast.

- Scattered fibroglandular densities. (ACR b)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin, nipple/areola.
- Non-specific axillary LNs.

Conclusion: -

- ***Left breast (BIRADS 2): Post-Therapeutic sequalae.***
- ***Right breast (BIRADS 1): Normal study***

Recommendation: -

- ***For annual follow up.***

Best Regards,

DR. Dina Sayed ,Msc.CUDBIT

BIRADS classification of breast lesions according to the American College of Radiology used for breast assessment combined with recommendations:

Category & recommendations	Suspected Cancer Risk
BIRADS 0: Non-informative study.	
BIRADS 1: Normal study, routing screening	0 %
BIRADS 2: Benign findings, routine screening	0 %
BIRADS 3: Probably benign, for close follow up.	2 %
BIRADS 4: Probably malignant, for biopsy.	50 %
A: mild suspicion.	
B: moderate suspicion.	
C: high suspicion.	
BIRADS 5: Malignant, for biopsy.	98-100%

[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]
Mammogram

Medical No. : 10804

Patient's Name: Nasra Abdel-Aziz Ahmed Nasr

Date: 2026-10-17

Referred by: Prof.Dr. no doctor

Hospital: Goustave Roussey International Egypt

Dr Amal Hegazy